第七章 以家庭为单位的健康照顾


本章数字资源

学习提要

- 理解家庭结构、家庭角色、家庭功能、家庭生活周期的特点及各阶段的照顾重心。
- 认识家庭资源、家庭危机及其重要性。
- 知悉家庭评估的意义和方法。
- 了解家庭对健康和疾病的影响。
- 了解家庭照顾的意义和方法，领悟临终关怀的人文精神。
- 树立以家庭为单位照顾的学科知识和思想。
- 转变医学观，以新的观念审视疾病和健康。

全科医学的理念是“将医疗保健引入家庭，为家庭提供一个完整的照顾”。而“以家庭为单位的健康照顾”是这一学科的核心和总体价值观。全科医生在评价健康问题时，除了考虑患者的生理疾病，也应该考虑家庭因素，了解家庭对健康和疾病的影响。实施这一人性化的基层医疗，应该熟悉家庭医生服务的内容，包括提供以家庭为背景的健康照顾；在家庭生活周期的不同时段，主动提供可预测性的健康照顾；处理家庭事件及家庭危机，实施家庭评估及家庭治疗；提供生命末期的体恤及团队式的临终服务。形成以家庭理念为指导的医疗方式和态度，围绕家庭单位开展健康照顾，这是全科医学有别于其他专科医学的特征，全科医学始终贯彻三级预防和浓厚的人文精神。

第一节 | 家 庭

一、家庭的定义

家庭（family）是人在社会中生存而产生的普遍而特殊的社会团体。人类总是以家庭的形式生存，因此，我们对家庭这一名词并不陌生，但要为家庭下一个确切的定义却并不容易。

（一）传统的家庭

“在同一处居住的，靠血缘、婚姻或收养关系联系在一起的，两个或更多人组成的单位。”传统家庭依靠法律的认可和保护，一般能维持终生的关系，家庭上下辈多有血缘关系，极少部分为领养关系，主要是指以一对男女为核心繁衍的家庭系统。

（二）广义的家庭

“一对在一起生活了 6 个月以上的男女核心组合单位。”强调只要家庭的稳定关系维持在 6 个月以上，即视为“家庭”。此种概念适合于西方的习俗，包含了更广泛的具有家庭性质的男女组成单位。

（三）演化的家庭

“成员在遭受躯体或感情危机时，能提供帮助和支持的一些亲密者组成的社会团体。”其定义将不具备传统家庭结构的团体也包含其内，比如像同性恋家庭、群居体等类型的团体。

（四）较完善的家庭

“家庭是通过情感关系、法律关系和生物学关系连接在一起的社会团体。”这一定义涵盖了现代

的各种类型家庭，突出了法律婚姻、血缘和情感三大要素。

从社会学角度来看，关系健全的家庭应包含 8 种家庭关系，即婚姻关系、血缘关系、亲缘关系、感情关系、伙伴关系、经济关系、人口生产与再生产关系、社会化关系。随着时代的发展，出现了变异的家庭组合，如单身、单亲、同居等。人们的目标是建立一个幸福和睦的健康家庭，而家庭的离合与变异，带来的却是复杂的心理行为和健康问题。因此，提供以家庭为单位的健康照顾不仅行之有效，也更显得人性化。

二、家庭的结构

家庭结构（family structure）是指家庭组成、类型及各成员间的相互关系，包括家庭的外在结构和内在结构。外在结构即家庭的类型。内在结构包括家庭的角色、权力结构、沟通形式（相互作用模式）和家庭的价值观。

（一）家庭的类型

1. 核心家庭（nuclear family） 是指父母及未婚子女组成的家庭，也包括无子女夫妇和养父母及养子女组成的家庭。现代社会中，核心家庭逐渐成为主要类型。核心家庭的特征主要体现在：规模小、家庭人数少、结构简单、关系单纯、只有一个权力和活动中心，其利益及资源易于分配，便于作出决策等。从医疗保健的角度考虑，核心家庭的家庭资源较其他家庭类型少，家庭关系存在着亲密和脆弱的两重性，温馨的家庭给成员带来幸福，促进学习和工作，且适应于快节奏的社会；但同时也导致了离婚率增高、留守儿童等家庭问题，给家庭保健带来了新的任务。

2. 扩展家庭（extended family） 指由两对或两对以上夫妇与其未婚子女组成的家庭。根据成员结构不同，扩展家庭又可分为主干家庭和联合家庭。

（1）主干家庭（linear family）：是指由一对已婚子女同其父母、未婚子女或未婚兄弟姐妹构成的家庭，包括父母和一对已婚子女及其孩子所组成的家庭，以及一对夫妇同其未婚兄弟姐妹所组成的家庭。主干家庭是核心家庭的扩大，有一个权力中心，或者还有一个次中心。因其具有直系血缘关系和婚姻关系，也称为“直系家庭”。

（2）联合家庭（composite family）：主要指至少两对或两对以上的同代夫妇及其未婚子女组成的家庭。联合家庭结构复杂、人员庞大，因此又称为“复式家庭”或“大家庭”。

扩展家庭同时存在一个或一个以上的权力中心和次中心，其结构复杂、关系错综，家庭功能受各方影响，出现问题常引起连锁反应，人际关系不易处理。但家庭内外资源丰富，易于应对压力事件。这类传统的大家庭已经越来越少，现代社会从大家庭到小家庭的变化已成趋势。

3. 其他类型家庭 包括单亲家庭、单身家庭、丁克家庭、同居家庭、独居家庭、群居体家庭、同性恋家庭、少年家庭（即由 18 岁以下的少年及其子女组成的家庭）等。这些非传统形式的家庭形态有其特殊的心理行为及健康问题。面对时代的客观现实，研究和照顾这些特殊家庭也是全科医学的范畴。

（二）家庭的内在结构

家庭的内在结构是指家庭内部的运作机制，是对内部运动关系的描述，反映家庭成员之间的相互作用和相互关系。家庭的权力结构、家庭角色、家庭成员的沟通方式和家庭的价值观形成了家庭的内动力。每个家庭都有其传统和特点，构成了不重复的家庭。

1. 家庭的权力结构（family authority structure） 家庭的权力结构是全科医生进行家庭评估和家庭干预时的重要参考资料，反映了谁是家庭的决策者，以及作出决定时家庭成员之间的相互作用方式。社会变迁，家庭权力结构除了受到家庭所在社会传统习俗影响，其形成还受感情和经济等因素的影响。专制的家庭权力形式正在向自由、民主的家庭权力形式转变。家庭的权力结构可分为以下四种类型。

（1）传统权威型：以社会传统确认家庭的权威。如传统公认的父亲、长子，而不考虑其社会地位、职业、收入、健康、能力等。

（2）工具权威型：负责供养家庭、掌握经济大权的人。如长兄、长姐，供养家庭的主角。

（3）感情权威型：在家庭感情生活中起决定作用的人主宰大权，其他的家庭成员因对他（她）的感情而承认其权威。如母亲、妻子。

（4）分享权威型：家庭成员均可分享权力，共同决策、共同承担家庭义务，以个人的兴趣和能力为家庭贡献力量。这是理想的家庭权力类型，民主平等的氛围有利于个人的健康成长和家庭的发展。

2. 家庭角色（family role）　是家庭成员在家庭中的特定身份，代表着他（她）在家庭中所应承担的职能，反映出他（她）在家庭中的相对位置及与其他成员之间的相互关系。在家庭中，每个成员都扮演着各自的家庭角色，这种身份是社会客观赋予的，而不是自己认定的。每一角色都代表着一套行为和社会标准。由此，人们也依其标准和行为模式去衡量和辨认角色。每个人都可能同时有几种不同的角色，如一个人可以是儿子、学生、班长。且随着时间的推移，角色也在不断变化，如女儿→母亲→奶奶。由于角色的变换，产生了角色期待、角色学习、角色认知、角色冲突的内涵与机制。对角色的认识可以帮助全科医生科学地评价家庭角色的扮演是否成功，了解家庭成员如何调适不成功的角色，如何适应角色的变换。

（1）角色期待：是指家庭对成员应表现出特定行为的期待。角色期待包含了复杂的综合转变，如对家庭、社会的认知，实践体验、情感态度的转变等。家庭对每一成员的角色期待都有传统的规范，如母亲的传统角色被赋予情感和慈爱的形象，她的职责是生育和抚养子女，做“女性”行为的典范；“丈夫”的传统角色被认为是养家糊口、负责作出家庭重要决策等；“儿童”的角色被认为是被动和服从，包括孝敬父母、完成学业、实现父母愿望等。不同家庭对成员的角色期待并不相同，因此，形成了不重复的角色。角色期待也会因时代不同而有所改变，儿童的健康成长与家庭的角色期待是分不开的，健康的角色期待对个体起到关心和促进成长的积极作用，是自我实现的动力；异常的角色期待，会使人出现病态人格。家庭的角色期待对成员社会化至关重要。既符合家庭期待，又符合社会规范，才是理想的期待角色。

（2）角色学习：角色学习是一种综合性的学习角色的情感、态度及拥有的权利和责任的行为。角色学习在人与人的互动和角色互补中进行，传统的角色模式也树立了效仿的榜样。因此，角色学习是一个变化发展的过程，人生的角色学习是无止境的，并要不断适应变化的角色（图 7-1）。角色的规范也随社会文化背景的变化而有所改变，如传统操持家务的女性，现在也是养家糊口的主力军。传统被动角色的儿童，现已成为家庭平等的一员，享受与父母同等的评价。

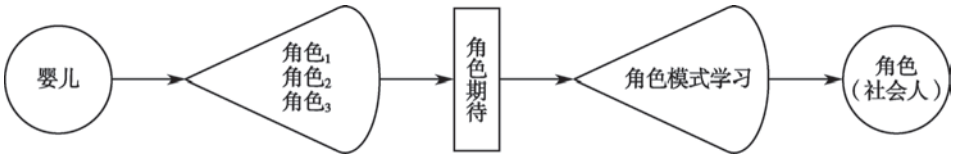


图 7-1　角色学习与发展过程

（3）角色认知：根据一个人的言行举止识别其地位和身份，称为角色认知，如“他像个干部”“她像个教师”。角色认知的同时伴随着角色评价。家庭中常常进行角色评价，良好的角色评价对家庭成员是一个鞭策，如母亲告诉哥姐应谦让弟妹、多做家务；父亲教育子女要好好学习、努力工作等。家庭角色的不断学习和评价，是进入合格角色和家庭成员社会化的重要过程。

（4）角色冲突：当个体不能适应其角色期待或角色转变时，便会在内心产生矛盾和冲突，称为角色冲突。角色冲突可在扮演一种或几种角色时发生。

1）不同的期待对同一角色：如母亲和老师向孩子灌输不同的是非标准，使其茫然、不知所措。

2）实际人格与角色不符。

3）同一个体扮演几个角色：如母亲的儿子、妻子的丈夫，夹在母亲和妻子之间，如缺乏角色的弹

性，会导致心理的困惑。

4）新旧角色转换：如从女儿转换为儿媳，常会发生心理不适。

角色冲突会导致个人心理功能紊乱，严重时出现躯体功能障碍，甚至影响家庭正常功能。因此，家庭中健康的角色期待极为重要。其需要建立在良好的家庭功能上，表现为：①家庭对某一成员的角色期待的一致性；②角色期待能满足成员的心理需要；③角色期待符合社会规范和自我个性发展；④对角色的转变富有弹性；⑤家庭成员都能适应自己的角色模式。家庭的内在动力极为复杂，应该认识到家庭角色良好是健康的保障。足够重视家庭角色，帮助家庭成员认识角色的转换，调适不良的角色，可早期预防心理伤害和家庭功能不良。

3. 家庭沟通（family communication） 沟通是家庭成员间相互交换信息、沟通感情、调控行为和维持家庭稳定的有效手段，也是评价家庭功能状态的重要指标。家庭沟通通过发送者（S）、信息（M）和接受者（R）完成，即 S-M-R 传递轴。这 3 个环节中任一环节出现问题，都会影响沟通的效果。发送者信息表达不清、缺乏信息、表达错误、信息模棱两可、含沙射影；信息活跃（增多、灵敏、超前）、信息减少、信息中断；接受者对信息不能理解、不愿接受、心不在焉、理解错误，都不能达到良好的沟通效果而产生负面影响。

Epstein 描述了家庭沟通的内容与方式。

（1）沟通的内容：属于情感性的内容称为情感沟通，如“我爱你”“我非常高兴”等；属于一般信息或与居家生活动作有关的内容称为机械性沟通，如“去端饭”“明天换休”等，为家庭的一般用语。

（2）沟通的信息：信息是清楚的，还是经过掩饰的；是直接坦率的，还是模棱两可、含糊其辞的。如“这本书不适合小孩看”，表达得很清楚；“电视看多了对眼睛不好”，是经过掩饰的信息，藏有不支持看电视的含义；“去不去都行”，是模棱两可的信息，无法认定去还是不去。

（3）沟通的信息是否直接指向接受者：是直接的，称为直接沟通，比如“我晚上不回来了”；是间接的或影射的，称为掩饰或替代性沟通。

家庭功能良好时，成员间亲密和睦、彼此知心，语言不加遮掩、不拐弯抹角。当家庭功能不良时，出现成员间的沟通异常，语言掩饰、交流不顺畅。一般来讲：①家庭功能早期不良表现为情感沟通受损；②家庭功能中度不良表现为替代性或掩饰性沟通；③家庭功能严重障碍表现为机械性沟通中断，缺少相互合作。温暖和睦的家庭沟通良好，人人向往；直接明快的沟通，应该为社会所提倡。

4. 家庭价值观（family value） 家庭价值观是指家庭判断是非的标准，以及对某件事情的价值所持的态度。家庭是社会的基本单位，也是个人人生第一次教育历程的场所，许多人格、观念的养成都是在家庭中奠定基础的。同时，家庭还是人类发展互动关系中的第一个社会世界，家庭价值观在与父母的人际互动中潜移默化地被传递着，影响着个体日后的观念、态度和行为。如果一个家庭认为生死由天，那么很难说服他们施行促进健康的行动。因此，全科医生必须了解家庭的价值观，特别是家庭的疾病观、健康观，才能确认健康问题在家庭中的地位，进而与家庭成员一起制订控制健康问题的具体方案。

三、家庭的功能

家庭功能（family function）指的是家庭在人类生活和社会发展中的作用。家庭作为人和社会的主要连接点，同时与两个方面发生联系，具有满足家庭成员个人和社会最基本需要的功能。家庭功能可分为许多方面，并且会随着社会文化的发展而变化，有些功能退化直至消失，有些则得到强化。但某些最基本的功能始终存在，其满足了家庭成员在生理、心理及社会各个层次的最基本的需要。这些功能可归纳为六个方面。

1. 感情需求 家庭成员以血缘和情感为纽带维系彼此间的亲密关系，通过彼此的关爱和支持来满足爱和被爱的需要，以形成共同的感情基础。

2. 性和生殖的需求 生育子女、延续种族，家庭满足夫妻性的需要。

3. 抚养和赡养　抚养孩子、赡养老人是家庭不可推卸的责任与义务，同时也是人类和社会延续的保证。

4. 社会化功能　家庭具有把其成员培养成合格社会成员的社会化功能，是家庭成员社会化的主要场所。在日常生活中向家庭成员传授社会技巧和知识，发展其建立人际关系的能力，使其学会如何与同代和异代人相处，胜任自己的社会角色等。同其他具有社会化功能的场所，如学校、夏令营、社区等相比，家庭是完成社会化功能的最佳场所。人的身心发育特别是心理发育的关键时期，主要在家庭中度过。这个时期如果缺失了家庭应提供的支持和关爱，会对成年后的个体产生多方面的影响。

5. 经济功能　家庭是一个经济联合体，首先要满足家庭成员生存的基本需求，其次家庭成员也离不开家庭的经济支持，包括学习、深造、医疗等，以及对各种困难的帮助。

6. 赋予成员地位　合法而健全的婚姻家庭能够给予子女合法的地位。

四、家庭生活周期

家庭生活周期（family life cycle）是指家庭遵循社会与自然的规律所经历的产生、发展与消亡的过程。Duvall（1997）根据家庭在各个发展时期的结构和功能将家庭生活周期分为 8 个阶段，即新婚期、第一个孩子出生期、学龄前儿童期、学龄儿童期、青少年期、孩子离家期、空巢期和退休期。根据家庭生活周期的不同阶段（表 7-1），提供周全的可预测性的服务，已成为全科医疗有别于专科医疗的特色。

表 7-1　家庭生活周期

阶段	定义	主要面临的问题	保健服务重点
新婚期	男女结合	适应人际关系 预备做父母 性生活协调和优生优育	沟通与咨询 性生活与生育指导
第一个孩子出生期	最大的孩子介于 0~2.5 岁	妊娠与围产期 角色适应与压力 婴幼儿哺育与产后健康 婴幼儿异常与疾病	孕期检查与健康指导 哺乳、喂养指导及妇科处置 早发现、处理与转介，预防接种
学龄前儿童期	最大的孩子介于 2.5~6 岁	儿童身心发展问题 安全保护问题 传染病及呼吸道感染	发育指导与成长咨询 安全健康教育 预防、及时治疗
学龄儿童期	最大的孩子介于 6~13 岁	上学、学业问题与心理成长 听力、视力障碍与感染 营养与运动问题	心理辅导与家庭宣教 及早发现、处理与处置 健康宣教与疾病预防
青少年期	最大的孩子介于 13~30 岁	青少年心理问题 社会化与性问题	心理咨询与家庭辅导 青春期教育、性教育
孩子离家期	最大孩子离家至最小孩子离家	父母与子女间为成人间的关系 孤独感 慢性病来临 围绝经期	不宜过多约束成年子女，宜以精神支持辅助子女 心理健康咨询，发展自己的社交及多种兴趣 宣教及预防、定期体检 围绝经期保健
空巢期	父母独处至退休	心理问题 慢性病多发 经济与保健	健康与心理辅导 健康教育、预防与治疗、转介 规划与告诫、沟通技巧
退休期	退休至死亡	疾病及残障 安全与治疗问题 丧偶、死亡	家庭病床与慢性病管理 随访安全看护、与子女联系 团队合作与临终照顾

实际上，并非每个家庭都要经历上述 8 个阶段，家庭可以在任何一个阶段开始或结束，如一个人离婚后再婚。在家庭生活周期各阶段中出现任何重大生活事件，如乔迁新居、生子、患病等，都会对家庭成员的身心健康产生影响。因此，全科医生在为患者提供健康照顾时，除掌握人体正常的发育过程，还要了解患者所在家庭的发展过程和生活周期，根据家庭的不同发展阶段，预测和识别家庭在特定阶段可能或已经出现的问题，及时地提供咨询和健康教育，采取必要的预防和干预措施。

第二节 | 家庭资源与家庭危机

一、家庭资源

个人和家庭在发展过程中总会遇到各种困难、压力事件，严重时可导致家庭危机。此时家庭和个人将会寻求帮助，以应对困难、渡过危机。这种家庭为维持其基本功能，应对紧张事件和危机状态所需要的物质和精神上的支持被称作家庭资源（family resource）。家庭资源可分为家庭内资源（FAMLIS）和家庭外资源（SCEEEM）（表 7-2）。家庭资源充足与否，直接关系到家庭及其成员对压力和危机的适应能力，家庭资源可通过 ECO-MAP 图进行评估（详见第四节家庭评估）。

表 7-2 家庭资源

家庭内资源（FAMLIS）	家庭外资源（SCEEEM）
1. 经济支持（financial support）：家庭对成员提供的各种金钱、财物的支持	1. 社会资源（social resource）：亲朋好友及社会团体的关怀和支持
2. 维护支持（advocacy）：家庭对其成员名誉、地位、权利和健康的维护和支持	2. 文化资源（cultural resource）：文化、传统、习俗教育等方面的支持
3. 医疗处理（medical management）：为家人提供和安排医疗照顾的能力	3. 经济资源（economic resource）：来自家庭之外的收入、赞助、保险、福利等支持
4. 情感支持（love support）：家庭对成员的关爱及精神支持	4. 教育资源（educational resource）：教育制度、方式、水平、机会等
5. 信息和教育（information and education）：为家人提供医疗信息及建议，家庭内部的健康教育	5. 环境资源（environmental resource）：所居住社区的医疗设施、居家环境、公共环境等
6. 结构支持（structural support）：家庭住所或设施的改变，以适应患病成员的需求	6. 医疗资源（medical resource）：医疗保健机构、卫生保健制度及卫生服务的可及性、可用性

二、家庭生活压力事件

家庭成员在遇到问题时可以从其家庭获得支持，但同时家庭成员也可能会从其家庭遭遇很多的压力。生活压力事件会对成员造成强烈的心理刺激和伤害，甚至难以愈合，严重影响家庭的内动力。主要包括家庭生活压力事件、个人生活压力事件、工作生活压力事件、经济生活压力事件四类。压力是很难测量和研究的，目前最好的办法是通过观察重要生活事件对人的影响及其在疾病发生、发展中的作用来判定压力的程度。令人高兴的生活事件同样也可以产生压力。Holmes 和 Rahe（1967）在其研究中，让被调查者将 42 个最常见的生活事件按压力感的大小和调适的难易排序（表 7-3）。结果发现，15 个最具压力的生活事件中有 9 个是家庭生活压力事件，说明家庭成员绝大多数压力来源于其家庭内部。该表中的评分反映的是西方社会文化背景中各种生活事件的压力大小，在不同的社会文化背景下，评分必然会有所不同。

NOTES

表 7-3　生活压力事件评分　　单位：分

家庭生活事件	评分	个人生活事件	评分	工作生活事件	评分	经济生活事件	评分
配偶死亡	100	入狱	63	被开除	47	经济状况的较大变化	38
离婚	73	较重的伤病	53	退休	45	抵押贷款在 1 万美元以上	31
分居	65	性功能障碍	39	较大的工作变化	39	抵押品赎回权被取消	30
亲密家属死亡	63	好友死亡	37	换职业	36	抵押贷款在 1 万美元以下	17
结婚	50	杰出的个人成就	28	职责的较大变化	29		
夫妻和解	45	开始/停止上学	26	与上司有矛盾	23		
家庭健康的重大变化	44	生活条件的较大变化	25	工作条件较大变动	20		
妊娠	40	生活习惯的大变化	24				
新家庭成员加入	39	转学	20				
与妻子大吵	35	搬家	20				
子女离家	29	娱乐的较大变化	19				
姻亲矛盾	29	宗教活动的较大变化	19				
妻子开始/停止外出工作	26	睡眠习惯的较大变化	16				
家庭团聚的变化	15	饮食习惯的较大变化	15				
		放假	13				
		圣诞节	12				
		轻微的违法行为	11				

我国家庭生活压力事件大体分为以下几种。

1. 地位改变　突然贫穷或富有、失业、领不到工资、失掉耕地或房屋等。

2. 失落　离婚、出走、被抛弃、分居、孩子或配偶死亡、私奔、不停变换工作等。失落是一种不但失去而且无望的感觉，使人心理退缩。

3. 家庭负担加重　长期或严重疾病、经济压力（上学、买房、看病）、意外妊娠、收养、继父母带来的兄弟姊妹、长期外出打工、留学、老人照顾等。

4. 道德行为问题　家庭暴力、少年犯罪、酗酒、吸毒、成员犯罪、通奸、亲子鉴定、辍学、病态人格等。

三、家庭危机

家庭危机（family crisis）能否发生，取决于生活压力事件的性质、大小，资源的多寡，决定因素则是事件的性质。小的生活压力事件，通过家庭的努力而摆脱，家庭功能尚可保持正常，恢复良性机制。严重的生活压力事件，则可能导致家庭中枢失助、失衡，使家庭功能处于瘫痪状态，产生家庭危机。

当一些慢性的生活压力事件逐渐积累到超过个人和家庭的承受限度时，家庭便会出现耗竭性危机，家庭功能将会进入彻底的失衡状态，影响家庭的和谐稳定，家庭功能失衡主要表现在以下方面：

①婚姻或性困境，如分居、离婚等；②一个家庭成员出现多重异常表现，又称为“厚病历综合征”，表现为某个家庭成员反复就医，但无法确诊的现象；③多个家庭成员出现多重异常表现；④孩子出现异常行为，如突然中断同家人的正常交流、说谎、逃学、离家出走等；⑤患者不易相处，如遵医嘱性很差、难以管理；⑥妊娠期间或产后出现异常行为；⑦家庭成员有药物或酒精成瘾现象；⑧有对妻子或孩子实行性虐待或家庭暴力的迹象；⑨精神失常；⑩易患疾病；⑪不断增加的紧张或焦虑情绪；⑫主诉有慢性疲劳或失眠。

家庭危机产生的原因各不相同：①家庭生活压力事件常引发家庭危机，但家庭危机并非都来自家庭生活压力事件；②家庭的异常互动模式、不成功的角色、不完整的结构、病态人格等，也可导致家庭危机；③家庭危机的概率与社会因素相关，情感、经济、价值观的突变，导致家庭危机事件增多；④亚婚姻灰色地带，使爱情忠贞成为泡影；⑤稳定家庭在市场经济中也面临受到冲击的风险。引起家庭危机的常见原因如表 7-4 所示。

表 7-4 引起家庭危机的常见原因

原因	一般情况	异常情况
1. 家庭成员增加	结婚、孩子出生、领养幼儿 亲友搬来同住	意外妊娠 继父、继母、继兄弟姐妹搬入
2. 家庭成员减少	老年家人或朋友去世 家人按计划离家（如孩子外出工作等） 同龄伙伴搬走	子女离家出走 家人从事危险活动（如战争） 家人或朋友住院 夫妻离婚、分居或被抛弃 家人猝死或暴力型死亡
3. 不道德事件	违反社会/社区/家庭的规范	酗酒、吸毒 对配偶不忠 被开除或入狱
4. 社会地位改变	家庭生活周期进入新阶段 加薪、提降职位 搬家、换工作、转学 事业的成败 政治及其他地位的变化 退休	代表社会地位的生活条件改变 失去自由（如入狱） 失业、失学 突然出名或发财 患严重疾病，失去工作能力 没有收入

丰富充足的家庭资源可对家庭成员的健康起到一个很好的支持作用。全科医生可与患者及其家属通过访谈等方式，了解患者的家庭资源状况，并对其能利用的家庭内外资源作出评估和判断。当家庭内资源不足时，应充分发挥自身协调能力，帮助患者及其家庭积极寻找、利用家庭外资源，以应对家庭生活压力事件或度过危机。

第三节 | 家庭对健康和疾病的影响

全科医生日常所照顾的有各种生理、心理症状及表现的病人，并不是孤立存在的，而是生活在与其息息相关的家庭背景中的。家庭对个人健康和疾病的发生、发展有着重要的作用；反过来任何家庭成员的疾病也会影响其他家庭成员的健康，甚至影响整个家庭的功能。因此，要提供周全的家庭照顾，全科医生必须了解家庭，剖析家庭的文化、功能和其内在的机制，引导“家庭健康”。

一、家庭系统理论

家庭系统理论是一种能较好地解释家庭对健康和疾病作用机制的学说。其发展过程大致分为三个阶段。第一阶段：医生（尤其是精神科医生）及其他研究者（特别是社会学家和流行病学家）开始认

识并研究家庭因素，如家庭结构、婚姻、沟通类型及丧偶等是如何影响个体的心理和生理健康的；第二阶段：在一些家庭治疗专家的理论实践基础上，初步形成了关于家庭问题的产生、个体治疗与家庭整体治疗的区别的理论框架和知识体系；第三阶段：在医学学科内产生并发展了家庭系统理论，这也是家庭医学产生的起点。

家庭生活周期是循序渐进的过程，起自男女的结合，终止于夫妻衰老死亡。家庭除进行生物及行为的正常传递，还会出现不可预测的躯体、心理、社会问题及危机。全科医生应关注家庭对个体健康的影响及个体健康问题对家庭的冲击，把家庭看作一个整体，提供以家庭为单位的照顾。

二、家庭与健康和疾病

（一）家庭与健康

1. 家庭饮食、生活、行为习惯与健康　慢性病的诱因多与不良的生活方式、饮食习惯、行为和心理相关，而这些诱因多来自家庭，如高盐饮食、高脂饮食、大炖大煮、鲜炒生食、缺乏运动、缺乏良好的卫生习惯、紧张行为等。不良行为与习惯在慢慢蚕食着人的健康。

2. 婚姻与健康　夫妻相亲相爱、家庭稳定，使家庭具有凝聚力，良好的家庭氛围能促使机体的生理、心理平衡，子女健康成长。不幸的婚姻、离婚、分居或寡居，对家庭成员都有冲击，带来负面情绪。高度负面情绪常会越过生理阈值导致疾病危机，如焦虑、疲劳、睡眠困难、偏头痛甚至是溃疡病、心理退缩等。重建的双核心家庭，往往带来角色的压力，情绪耗尽、透支健康。在针对离婚、寡居、丧偶家庭的调查中发现，此类家庭死亡率比婚姻家庭高很多。家庭破裂是健康的重要危机，且对孩子有广泛影响，导致倒退、发育迟缓、学校问题、行为问题、学习失败，焦虑、抑郁、厌倦、犯罪、性乱、自杀等。

3. 家庭与成长　患儿非发作性惊厥与低社会阶层、精神疾病、父母亲情剥夺和不良保健有关；意外事件及安全伤害的发生明显与父母防范意识薄弱相关；儿童尿床与低社会阶层、父母照顾不良有关；神经质母亲的孩子也有可能神经质；人格障碍也多与家庭环境及家庭教养有关；富足家庭能满足儿童所需的营养及关爱，长期营养缺乏会影响发育成长。

4. 家庭对儿童社会化的影响　儿童的躯体和行为异常与家庭病理有密切的关系。父母亲情的长期剥夺与自杀、抑郁相关。人在 3~5 岁时奠定人格基础，可以说父母造就了儿童的人格。家庭不良的互动模式是家庭病理的起因，人际沟通不良常在家庭的互动中形成。

5. 家庭经济与健康　经济社会形成了富有与贫穷两极分化的家庭，经济对健康的影响与年龄有关，年龄越小，相关性越大。肥胖儿童是糖尿病、动脉硬化、心血管病等“慢性病”人群的“后备军”。成人脂肪肝、胰腺炎等常是饮食不节的后果。而营养供给不足使儿童发育迟缓，导致营养不良症。因病致贫、贫病交加，导致家庭挫败，不利于家庭成员的发展。

6. 家庭关系不良与健康　国外研究发现，父母长期高应激状态对子女智力和行为都有影响。家庭暴力对躯体和精神有严重影响，可留有心理创伤，恶性循环使子女精神紧张、思维减退、表现异常。家庭照顾及心理支持缺乏或丧失，子女的安全感、感受到的关爱等也发生相应变化，会使子女身心憔悴、自尊心下降，出现多动、说谎、逃学、偷窃、攻击、酗酒、滥用药物、离家出走、过早性行为、犯罪、自杀等行为。

（二）家庭与疾病

1. 家庭与遗传病　每个人都是其基因型与环境相互作用的产物，某些疾病就是受到家族遗传因素和母亲孕期各种因素的影响而产生的。遗传病的获得不仅仅是生物遗传，还有心理、精神的遗传。家族性遗传病有血友病、β-地中海贫血、克汀病等；许多慢性病也都有家族遗传倾向，如高血压、动脉粥样硬化、糖尿病等；家庭病理也可通过母亲的情绪-神经-内分泌轴对胎儿产生影响，持续焦虑的母亲所生的孩子有神经系统不稳定倾向，神经质人格在家庭重复出现，人格品质常遗传至下一代。一个家族的素质，上下代际常具有相似性。

2. 家庭与感染　传染性疾病及呼吸道疾病在家庭中更易传播。如肝炎、艾滋病呈家庭聚集现

象;0~5 岁孩子下呼吸道感染及其严重程度与不利的家庭因素有关;3~7 岁儿童发生哮喘与父母的抑郁、焦虑相关;孩子发生链球菌、葡萄球菌感染及肠道感染,与不良居家环境、过分拥挤、缺乏家庭照顾相关。

3. 家庭与慢性病 慢性病的长期照顾多依靠家庭,患者的生活质量及预后与家庭照顾相关。据调查,获得足够家庭关注的糖尿病患儿,病情能得到更有效控制,发育正常;而家庭关注不足的患儿,并发症多、容易中途夭折。就慢性病的病情控制和提高患者生活质量而言,家庭照顾极为关键。

4. 家庭与疾病预防 科学研究认为,动脉脂质沉积从两三岁就已经开始出现,到成年出现症状时已是不可逆的变化,可见疾病预防应从家庭做起,从生活方式、健康心理行为方面着手,方能保障家庭成员的健康。家庭功能良好、相互作用模式正常,可有效预防心理疾病。

5. 家庭与疾病康复 家庭的支持对各种疾病,尤其是慢性病的治疗和康复有很大的影响。Anderson 等人(1981)发现,糖尿病控制不良与低家庭凝聚度和高冲突度有关。家长的漠不关心可导致最严重的糖尿病失控和患儿患抑郁症(Khurana & White,1970)。

第四节 | 家庭评估

家庭评估(family assessment)是完整家庭照顾的重要组成部分,其目的是了解家庭的结构、家庭所处的家庭生活周期阶段、家庭资源和家庭功能等,进一步分析家庭存在的健康问题/疾病,以及在照顾患者健康问题/疾病过程中可以利用的家庭资源。

全科医疗中广泛应用的家庭评估方法有:家庭基本资料收集、家系图、家庭圈、家庭功能 APGAR 量表、生态图、家庭凝聚度和适应度等。家庭评估是对家庭资料的综合分析,以得出个体或家庭问题的解决途径。

一、家庭基本资料

家庭基本资料包括:家庭环境、家庭各成员的基本情况(姓名、性别、年龄、家庭角色、职业、教育、文化、婚姻及主要健康问题等)、家庭经济状况(经济来源、年均收入、人均收入、消费观念等)、家庭健康生活(家庭生活周期、家庭生活事件、生活方式、健康信念等)等。收集家庭基本资料是全科医生做家庭评估最为常用、最为简便的方法。

二、家系图

家系图(genogram,family tree)可用来描述家庭结构、医疗史、家庭成员的疾病有无遗传、家庭关系及家庭重要事件等。利用家系图可迅速了解被评估家庭的整体情况,提供连续性和综合性的照顾,识别家庭成员中的危险因素、筛查高危患者,有针对性地促进生活方式的改变并加强患者教育,与被评估家庭建立和谐的关系。家系图可作为家庭档案的基本资料存于病历中。家系图的画法应遵循以下原则。

1. 内容一般包括三代人。
2. 可以从最年轻的一代开始往上追溯,也可以从患者这一代开始上下展开。
3. 不同性别、角色和关系用不同的结构符号来表示。
4. 同代人中年龄大的排在左边,年龄小的排在右边,并在每个人的符号旁边注上年龄、出生或死亡日期、遗传病或慢性病等资料。还可以根据需要,在家系图上标明家庭成员的基本情况和家庭中的重要事件。
5. 标出在同一处居住的成员。
6. 家系图中的符号要简明扼要。

家系图一般可在 10~15 分钟内完成,其内容可不断积累和完善。在全科医疗中有较高的实用价值。家系图范例和符号如图 7-2。

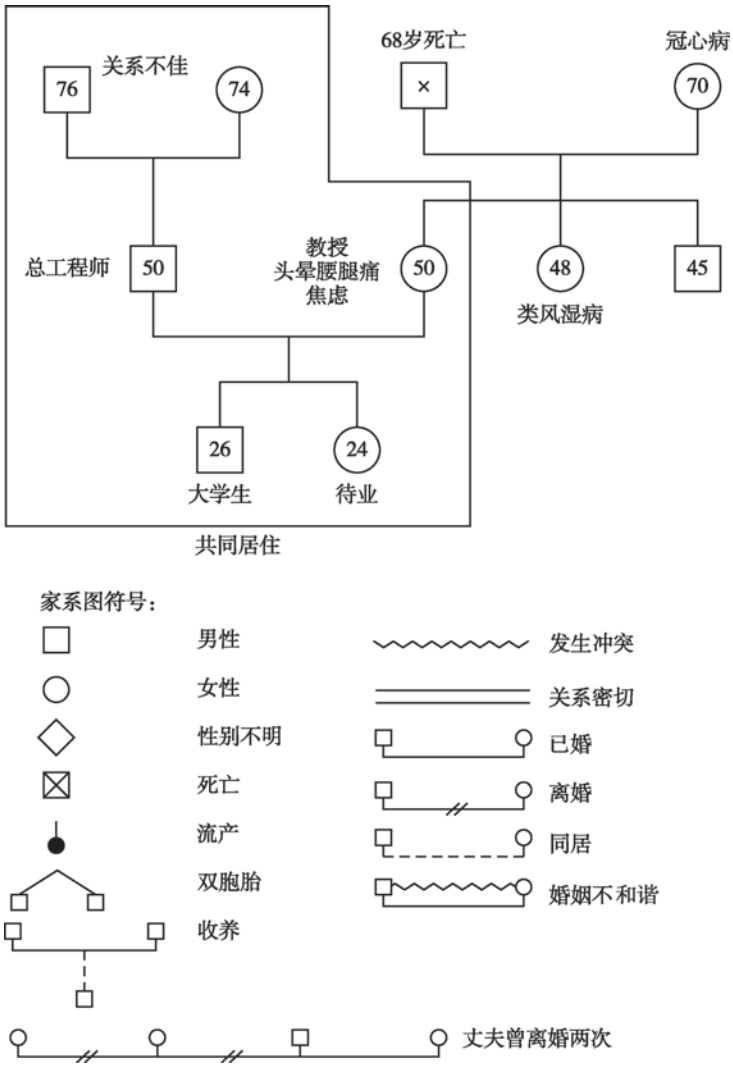


图 7-2　家系图范例及符号

三、家庭圈

家庭圈（family circle）是患者从自己的角度看待家庭成员与自己的关系，自绘的圈形图，是一种患者主观评价的方法。在图中，家庭以大圈表示，成员以小圈表示，小圈的距离代表其亲密度，绘图者将自己绘于大圈的中心位置，其他成员按亲密程度绘于周围。也可将自己生活中的重要宠物绘于图中，如狗、猫等。家庭圈随着个人观点的改变而变化，因此，情况变化后需要重绘，以便医生获得新的资料及进行下一步咨询。家庭圈有利于医生探讨家庭的互动关系及家庭的动态表征。家庭圈范例如图 7-3。

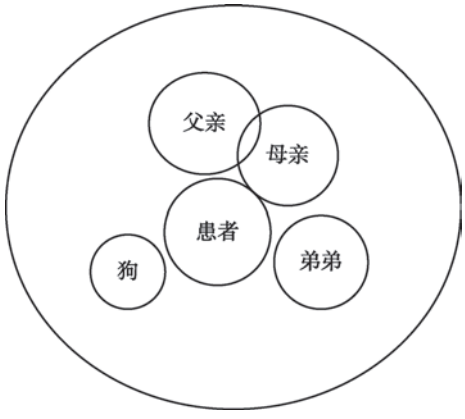


图 7-3　家庭圈范例

四、ECO-MAP 图

ECO-MAP 图，即生态图（图 7-4），是评估家庭外资源的一种方法。把家庭作为对象，调查家庭外资源有关成

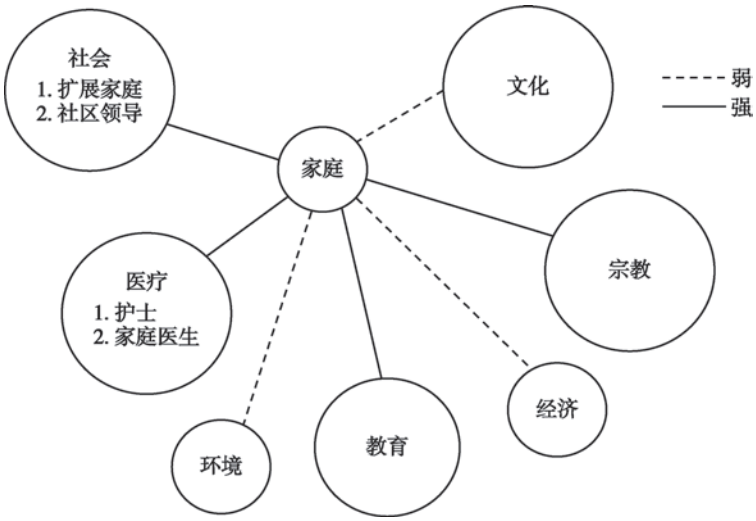


图 7-4 家庭外资源 ECO-MAP

分的有无及多少，记录各种资源成分与家庭的联系强度，图中圈的大小表示资源的多少，不同的连线表示联系的强度。该图以社会的观点进行家庭评估，有助于指出家庭所处社会环境的基本特质，亦可用于治疗。

五、家庭功能评估

家庭功能是衡量家庭系统运行状况的重要标志，也是影响家庭成员心理发展的深层变量之一。家庭功能是否良好，是家庭评估中很重要的一项。APGAR 家庭评估问题表是 Smilkstein 于 1978 年研究设计的检测家庭功能的问卷，主要用来测量家庭成员对家庭功能的主观满意度。因为问题较少，评分容易，因而比较适宜在基层工作中使用。APGAR 量表的名称和含义如表 7-5 所示，APGAR 量表的具体内容如表 7-6 所示。

表 7-5 APGAR 量表的名称和含义

名称	含义
1. 适应度（adaptation）	家庭遭遇危机时，利用家庭内、外资源解决问题的能力
2. 合作度（partnership）	家庭成员分担责任和共同作出决定的程度
3. 成长度（growth）	家庭成员通过互相支持所达到的身心成熟程度和自我实现的程度
4. 情感度（affection）	家庭成员间相爱的程度
5. 亲密度（resolve）	家庭成员间共享相聚时光、金钱和空间的程度

表 7-6 APGAR 量表

内容	2 分	1 分	0 分
	经常	有时	很少
1. 当我遭遇困难时，可以从家人那里得到满意的帮助			
2. 我很满意家人与我讨论各种事情，以及分析问题的方式			
3. 当我希望从事新的活动或发展时，家人都能接受且给予支持			
4. 我很满意家人对我表达感情的方式，以及对我的情绪反应			
5. 我很满意家人与我共度时光的方式			

NOTES

该量表共分为两个部分。第一部分为 APGAR 评估量表，主要用于测量个人对家庭的满意度。本表采用封闭式问答，共 5 个题目，每个题目设 3 个答案“经常”“有时”和“很少”，分别记分 2 分、1 分和 0 分。将 5 个问题的得分相加，总分 7~10 分表示家庭功能良好，4~6 分表示家庭功能中度障碍，0~3 分表示家庭功能严重障碍。另外，通过分析每个问题的得分情况，可以粗略了解家庭功能障碍的基本原因，即哪一方面的家庭功能出了问题。第二部分较为复杂，是了解测试者与家庭其他成员的个别关系，采用开放式的问答，能获得更多的资料，测试者将与每位家人相处的亲密关系及程度，分为良好、普通、不好 3 个等级回答。第二部分不在此叙述。

在使用 APGAR 评估量表时，应注意两个问题，首先是需要将本量表通俗化和本土化，但又不能失其精髓；其次是正确对待该表的测评结果，注意其时效性和主观性的特点。

六、家庭凝聚度和适应度

家庭凝聚度（family cohesion）是反映家庭成员之间的亲密及自主性程度。家庭的凝聚力是家庭的动力，凝聚度异常往往是家庭功能不良的原因。异常凝聚度家庭包括：缠结型（enmeshed）、联结型（connected）、分离型（separated）、破碎型（disengaged）。家庭适应度（family adaptability），即成员的适应力及家庭对生活压力事件的反应和调适能力。可分为：混乱型（chaotic）、灵活型（flexible）、有序型（structured）、僵硬型（rigid）。

家庭适应度和凝聚度评估量表（Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale，FACES）分为三种，分别用于成人家庭、有青少年的家庭和年轻夫妇双人家庭。每种问卷都由 30 个问题组成。每个问题的答案为“从不”“很少”“有时”“经常”和“总是”，分别记 1、2、3、4、5 分。在此仅列出 FACES Ⅱ成人问卷（表 7-7），供学习者研究和使用。

评价的步骤为：先将受试者所答各题的分数用表 7-8 的方法算出凝聚度和适应度得分；然后根据表 7-9 找出得分对应的凝聚度和适应度的性质；最后可判断出所评估家庭的凝聚度和适应度。也可以按照 circumplex 模型（图 7-5）判断该家庭所属的家庭类型。

表 7-7　FACES Ⅱ成人问卷

问题	从不	很少	有时	经常	总是
	1	2	3	4	5
1. 遇到困难时，家人能互相帮助	□	□	□	□	□
2. 在家里，每个人能自由发表意见	□	□	□	□	□
3. 同外人讨论问题比同家人容易	□	□	□	□	□
4. 作出重大的家庭决定时，每个家庭成员都能参与	□	□	□	□	□
5. 家庭成员能融洽地相聚在一起	□	□	□	□	□
6. 在为孩子定规矩时，孩子也有发言权	□	□	□	□	□
7. 家人能一起做事	□	□	□	□	□
8. 家人能一起讨论问题，并对作出的决定感到满意	□	□	□	□	□
9. 在家里，每个人都各行其是	□	□	□	□	□
10. 家务活由各家庭成员轮流承担	□	□	□	□	□
11. 家庭成员互相了解各自的好友	□	□	□	□	□
12. 不清楚家里有哪些家规	□	□	□	□	□
13. 家庭成员在做决定时同其他家人商量	□	□	□	□	□

续表

问题	从不	很少	有时	经常	总是
	1	2	3	4	5
14. 家庭成员能畅所欲言	□	□	□	□	□
15. 我们不太容易像一家人那样共同做事	□	□	□	□	□
16. 解决问题时，孩子的建议也予以考虑	□	□	□	□	□
17. 家人觉得彼此很亲密	□	□	□	□	□
18. 家规很公正	□	□	□	□	□
19. 家庭成员觉得同外人比同家人更亲密	□	□	□	□	□
20. 解决问题时，家庭成员愿意尝试新途径	□	□	□	□	□
21. 各家庭成员都尊重全家共同作出的决定	□	□	□	□	□
22. 在家里，家人一同分担责任	□	□	□	□	□
23. 家人愿意共同度过业余时间	□	□	□	□	□
24. 要改变某项家规极其困难	□	□	□	□	□
25. 在家里，各家庭成员之间互相回避	□	□	□	□	□
26. 出现问题时，我们彼此让步	□	□	□	□	□
27. 我们认同各自的朋友	□	□	□	□	□
28. 家庭成员害怕说出心里的想法	□	□	□	□	□
29. 做事时，家人喜欢结对而不是形成一个家庭群体	□	□	□	□	□
30. 家庭成员有共同的兴趣和爱好	□	□	□	□	□

表 7-8 计算凝聚度和适应度的方法

凝聚度	适应度
① 第 3、9、15、19、25、29 题得分之和	① 第 24、28 题得分之和
② 用数字 36 减去步骤①的结果	② 用数字 12 减去步骤①的结果
③ 其余所有奇数题及第 30 题得分之和	③ 其余偶数题得分之和（除外第 30 题）
④ 步骤②和③的结果之和	④ 步骤②和③的结果之和

表 7-9 凝聚度和适应度得分转换表

凝聚度	0~50	51~59	60~70	71~80
	破碎	分离	联结	缠结
适应度	0~39	40~45	46~54	55~70
	僵硬	有序	灵活	混乱

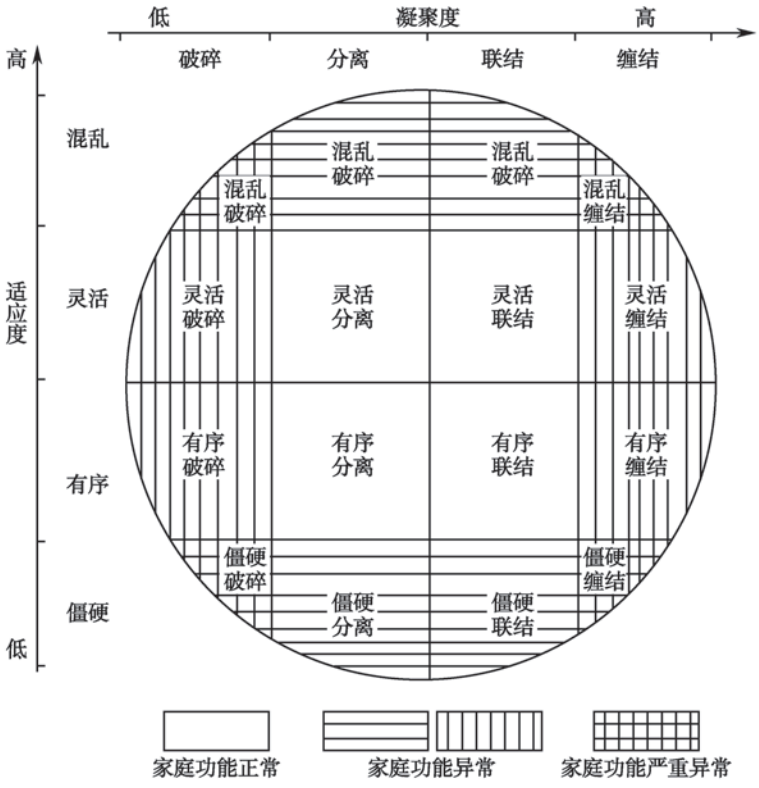


图 7-5　circumplex 模型（将家庭分为 16 种类型，Olson，1979）

第五节 | 家庭照顾

全面的患者照顾应考虑到患者的社会、家庭背景，考虑到家庭对患者疾病和治疗的作用。由于全科医生业务水平、时间、兴趣的差异以及患者期望的不同等原因，全科医生/家庭医生在行医中与家庭联系的程度也不同。Doherty 和 Baird（1986）将家庭医生的服务分为 5 个等级（表 7-10）。

表 7-10　家庭照顾的服务等级（Doherty 和 Barid，1986）

级别	内容
1. 对家庭的考虑最少	与家庭只讨论生物学方面的问题
2. 提供医疗信息和咨询	诊治中考虑家庭因素，能简单地识别家庭功能紊乱并转诊
3. 同情和支持	同家庭的讨论中，强调压力和情感对疾病和治疗的作用
4. 评估和干预	同家庭讨论，帮助他们改变角色和相互作用模式，以便更有效地适应压力、疾病和治疗
5. 家庭治疗	定期同家庭会面，改变家庭内与身心疾病有关的不良相互作用模式

许多西方国家初出茅庐的家庭医生，仅提供 1、2 级水平的家庭医疗；大多数家庭或全科医生，提供 3、4 级水平家庭医疗保健；而接受家庭治疗专门训练的家庭或全科医生，可提供 5 级服务。

一、家庭照顾中的三级预防

家庭是重要的压力来源，也是重要的资源。全科医生也应认识到家庭是预防疾病的重要资源，是实施预防措施的良好场所。对家庭的照顾，始终贯穿三级预防，并在家庭的参与下实施（表 7-11）。

表 7-11 家庭三级预防的实施

预防等级	内容
一级预防	生活方式相关问题指导 健康维护 家庭生活教育
二级预防	医患共同监测健康，心理咨询 鼓励及时就医，早发现、早治疗 监督遵医性，治疗及管理
三级预防	对慢性病成员持续性管理，督促遵医性，指导适当的活动能力 对慢性病患者带给家庭的变化，指导全体成员参与并作出相应调整 对重病或临终家庭，提供团队合作家庭照顾和临终关怀

二、家庭访视

家庭访视（home-visiting）是指在服务对象的环境里，全科医生利用其专业知识、技能为社区居民提供健康信息和健康咨询，从而达到促进和维持个体、家庭和社区的健康的目的。

（一）家庭访视的适用范围

1. 某些急症患者。
2. 行动不便者。
3. 有心理社会问题的患者。
4. 不明原因的不遵医嘱的患者。
5. 初次接诊的新患者。
6. 患多种慢性病的老人。
7. 临终的患者及其家庭。
8. 有新生儿的家庭。
9. 需要做家庭结构和功能评价者。
10. 需要实施家庭咨询与治疗者。

（二）家庭访视的种类

1. 评估性家访 对家庭进行评估。常用于有家庭问题或心理问题的患者及对老年患者家庭环境的考察。

2. 连续性家访 对慢性病患者或家庭病床提供连续性的照顾，或需要定期随访。

3. 急诊性家访 处理紧急事件。

4. 随机性随访 医生的意向及追踪。

三、家庭治疗

家庭治疗（family therapy）是指对家庭的功能、角色、互动模式的调适，涉及心理、行为问题的治疗。家庭治疗以家庭为对象，通过对家庭所有成员的协调，达到家庭和谐、功能运转正常的目的。

专业人员把家族视为一个整体，整个家庭是一个个案，其中可能有一个特定的案主，但治疗是对全家，而不是仅对案主。疏通家庭内部机制会改变整个家庭系统，而改变家庭可能是改变个人最有效的途径。一个家庭是一个系统，家庭发展则是一个系统的途径，家庭存在系统内部的相互制约与调整。“不改变家庭内部的相互作用模式而企图改变某成员的行为是极为困难的。”所以，实施家庭治疗，需要医生与家庭达成协议，动员所有家庭成员参与，了解家庭问题的来龙去脉、成员的角色状况、家庭相互作用模式以及成员的认知和行为，逐步改变家庭机制。这里提到的动员家庭成员参与可以理解为与家庭成员合作。从家庭治疗的观点出发，与家庭成员合作是指避免全科医生提供太多的指

NOTES

令性服务，为家庭的幸福负太多责任，这样会导致家庭将其健康和发展完全依赖于全科医生。从家庭教育的观点出发，与家庭成员合作是指提高预先指导的能力，帮助家庭成员做好准备，不仅要准备好如何面对家庭成长过程中发生的正常变化，还要准备好家庭系统如何面对疾病带来的影响。与家庭成员合作是家庭医疗的基础，家庭生活和谐不仅是家庭成员心理健康的基础，也是社会稳定的基础。

日常诊疗活动中，不可避免地会遇到因家庭问题引起的就医行为，全科医生应发挥自身优势，应用特有的家庭医学理论，适时提供帮助。家庭治疗，又被称为家庭心理治疗，是指针对家庭（成员）的心理问题而施行的团体心理治疗。然而，家庭治疗并非所有的全科医生都能做得很好，从事家庭治疗需要专业的训练。因此，全科医生应该审慎，认识到自我的不足，以自身能力为基础实施相应干预，保持与家庭的密切关系。值得注意的是，约定与家庭的会晤，如同临床的治疗方案，须一步一步调整，方可使家庭逐渐康复。

许多证据表明，21 世纪精神和心理问题将成为人群健康的主要问题，发病率增长迅速，多为社会原因所致。参与家庭治疗，需要拥有资深的心理学阅历并掌握精神分析的方法。治疗应该营造有益于精神放松的环境，为家庭治疗构建良好的家庭氛围。全科医生方便进行家庭照顾，也只有全科医生更懂得家庭。

1. 家庭治疗是全科医生介入复杂的家庭领域，调整家庭发展变化中的动态平衡过程，其内容只能在实践中增长经验。

2. 家庭治疗多为医生与来访者公开讨论对家庭事件的反应。

3. 家庭治疗所采用的方式应与事件的性质吻合。

4. 家庭治疗对身体健康及保健有积极的效果。

四、临终关怀

全科医学注重于研究生命周期，而临终是生命的最后里程，也是一种家庭危机。临终表明患者即将永远离开世界，传统指老人的死亡，实际上可发生在任何年龄甚至儿童。人类对死亡充满了恐惧，尤其是非正常死亡。医学界中甚至有人把死亡看作敌人，产生了强化及侵袭性的治疗，社会的进步提出了临终关怀。

临终关怀（hospice）的原意是济贫院、旅客招待所，产生于中世纪。到 1967 年，桑德斯博士（Dr. Dame Cicely Saunders）创办了英国第一家圣克里斯多佛临终关怀医院（St.Christopher's Hospice），此后，临终关怀在这所医院的起始下得以发展和推崇。它体现了人类的仁爱、同情和奉献精神，并使生命的照顾得以完满。临终关怀以综合、人性化、居家式的服务及提高临终生命质量为宗旨，提供身心一体的照顾，使临终者安然度过最后的时光。我国于 1988 年在天津医学院成立了第一所临终关怀研究中心，并逐步开展临终关怀事业。当前，面对我国社会人口的老龄化，社区医疗也将承担临终关怀服务的功能。

（一）总疼痛

桑德斯博士深感临终患者复杂的身心痛苦绝非仅限于肉体，她打破了传统的疼痛概念，从社会角度审视生命末期的感受，提出了“总疼痛”（total pain）的概念。总疼痛是指躯体疼痛（骨浸润痛、呼吸困难、便秘等）、心理疼痛（死亡恐惧、再见不到亲人等）、社会疼痛（离婚、失业、亲人早逝等）、灵魂疼痛（自责、内疚、悔过等）和经济疼痛（谁来养活孩子、偿还债务等）等多种疼痛的总体感受。

总疼痛诠释了躯体和心灵交织于一起的折磨，因此，缓解临终者的疼痛需要的不仅是单一的止痛药物，还包含对心理社会的支持及与止痛药的联合应用。应采用综合的措施，减轻肉体和心灵的折磨。

（二）联合止痛

联合止痛指实施治疗、心理看护、社会支持的综合措施，临床大体包括止痛药物、神经封闭、麻醉、医护呵护、居家团队合作及支持。

NOTES

1. 止痛

（1）疼痛的因素：止痛效果与医护成熟的思考和分析能力密切相关，因此，对疼痛应进行如下分析：①引起、加剧或缓解疼痛的因素；②疼痛的特征和性质；③疼痛涉及的部位；④疼痛的时间与规律；⑤疼痛对患者生活、情绪的影响，以及患者对疼痛的反应；⑥伴随或并发的症状。

（2）止痛药分类及 WHO 提出的三阶梯止痛原则见表 7-12。

表 7-12 WHO 三阶梯止痛原则

阶梯	药物
一阶梯，非阿片类药物，治疗轻度疼痛	阿司匹林、布洛芬、对乙酰氨基酚等
二阶梯，弱阿片类药物，治疗中度疼痛	可待因、曲马多等
三阶梯，强阿片类药物，治疗重度疼痛	吗啡、羟考酮等
辅助止痛药物	抗抑郁药、抗惊厥药、镇静剂、皮质类固醇等

2. 心理社会支持　临终关怀服务需要一支多学科的专业队伍，包括医生、护士、药剂师、法律顾问、协调人员、志愿者等。他们齐心协力满足临终者及家人的生理、心理、社会和经济的需要。临终关怀服务，应做到以下几点。

（1）耐心倾听、彻底实施：对于生物医学无法治疗的患者，心理、社会支持极其重要。耐心倾听患者意愿并彻底去做，会给他们的心灵带来无限安慰，明显提高其生命质量。①耐心倾听：耐心倾听患者的诉说，方能知其心声、进行理解与情感的沟通。接受患者的感受与体验，充分满足其临终前的要求，是最重要的心理支持。②减少孤独：尽量减少患者的孤独感。因临终者对亲人的无限留恋，希望有人陪伴，怕刹那间再也见不到亲人，所以避免临终者与家人隔离是医学界的进步与醒悟。③保持尊严、避免侵袭治疗：临终患者希望得到休息、平静和尊严，需要心灵呵护，应避免侵袭性、墨守成规的治疗。

（2）尊重患者的权利：临终关怀是一种姑息性治疗和照顾，在家中或医院环境中的服务都有效，重要的是尊重患者的选择。患者需要医生了解自己的心意，也需要从医生那里了解病情。美国精神科专家 Elisabeth Kubler-Ross 认为，大多数临终患者都会经受感性适应和死亡过程反应的 5 个阶段：否认期、愤怒期、商讨期、抑郁期、接受期，也有的只经过两三个阶段。因此，应根据患者的意愿如实告知病情，但要注意策略：①随病情发展慢慢告知实情，像脱敏注射一样实施心理脱敏，逐步增加患者的承受力。②通过对治疗预后的乐观态度，给予心理支持，唤起其战胜疾病的希望和毅力。③以语言和情感交流，对病情提供保守的推测。

（3）尊重生命质量胜于数量：临终关怀是为改变短暂的生命质量，而不是盲目地延长生命时间。临终关怀旨在为患者营造一个舒适、有意义、有尊严、有希望和温暖的生活空间，使其在有限的时间里没有痛苦折磨、与家人共度温暖时光，得到无微不至的关怀，平静安详地迎接死亡。国外多采用消极疗法，强调其精神护理：①让患者舒服：因为没有痛苦，才有生命质量；②灵性：耐心倾听，用肢体语言与心灵沟通；③细心体察：认真对待细小的环节与要求，悉心看护患者；④宁静：过日常平静的生活，包括与家人相处。

（三）帮助临终患者的家庭

临终关怀除围绕临终者的服务外，还包括对其家庭的照顾。

1. 团队人员为家庭提供支持，如对家人的治疗、帮助和指导。

2. 了解谁是最悲痛者、谁是竭力照顾者，他们是否也有健康问题，为其提供帮助，尤其是丧偶、丧子者。

3. 提醒家庭应为患者做些什么，比如满足最后遗愿，选择最后度过地点，安排居丧等。

4. 鼓励家人发泄，在长期的压抑下哭出内心的伤痛。

5. 安排邻居、亲友中有相同体验的人与难以解脱的成员进行交流。

6. 暂时脱离原来的环境，避免睹物思人。

人生有些伤害不可能依靠医治，有的需要情感的弥补，有的需要社会性治疗，有的需要通过时间的流逝来淡化。美国 1976 年立法《自然死亡法案》，对末期临终者不施以增加痛苦且拖延死期的治疗，即消极治疗。这些为临终关怀的社会和社区服务提供了思路和建议。

（肖　雪）

思考题

1. 如何理解以家庭为单位的健康照顾？
2. 家庭的内在结构及外在结构主要包括哪些内容？
3. 家庭生活周期及其划分的意义。
4. 如何充分利用和调动家庭资源来避免和应对家庭危机？
5. 举例说明家庭对健康和疾病的影响。
6. 家庭评估在全科医生诊疗过程中的作用和意义。
7. 请谈谈您对家庭照顾中三级预防的理解，您的家庭是否重视并做到了呢？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图

NOTES